

国家疾病预防控制中心综合司
国家卫生健康委员会办公厅 文件
国家中医药管理局综合司

国疾控综监测发〔2026〕22 号

关于印发《全国聚集性不明原因肺炎
监测方案》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团疾控局、卫生健康委、中医药局，中国疾控中心（中国预科院）：

为规范全国聚集性不明原因肺炎监测工作，国家疾控局、国家卫生健康委、国家中医药管理局联合制定了《全国聚集性不明原因

肺炎监测方案》。现印发给你们，请结合实际认真组织实施。



(信息公开形式:不予公开)

全国聚集性不明原因肺炎监测方案

为规范全国聚集性不明原因肺炎监测报告工作,及时发现新发突发呼吸道传染病疫情,特制定本方案。

一、监测目的

及时发现聚集性不明原因肺炎疫情,规范病例报告、检测、调查及先期处置工作,防范新发突发呼吸道传染病流行风险。

二、监测内容与工作要求

(一)监测范围。全国二级及以上医疗机构。

(二)监测内容和方法。

1.病例定义。在共同居住、生活、工作及其他存在流行病学关联的人群中,14天内发生2例及以上的,不能明确病原或临床认为常见病原无法解释的肺炎病例。

2.监测病例报告。

(1)医疗机构诊疗排查发现。医疗机构医务人员在日常诊疗过程中,尤其是在呼吸科、感染科、儿科、重症监护等科室诊疗住院肺炎病例时,应主动询问聚集性发病史、类似症状患者接触史等相关流行病学史,规范开展抗感染治疗等临床诊疗,必要时开展常见病原体(包括但不限于新冠病毒、流感病毒、肺炎支原体等)检测。当接诊医务人员经过上述诊疗排查后发现符合病例定义的患者

时,应于2小时内 在传染病疫情网络直报系统中报告聚集性不明原因肺炎,并同时报告属地县级疾控机构。

(2)疾控机构监测排查发现。省级疾控机构可在省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台(以下简称省统筹平台)汇聚本省份国家传染病智能监测预警前置软件(以下简称前置软件)数据,使用模型(规则见附件)自动识别聚集性肺炎风险,并将风险信号推送至县级疾控机构。县级疾控机构应组织病例当前或最后一次就诊医疗机构进行排查。符合病例定义的,医疗机构应于2小时内 在传染病疫情网络直报系统中报告聚集性不明原因肺炎。

3.样本采集、运送与检测。

医疗机构应于病例样本采集后24小时内,将其运送至县级疾控机构。样本包括呼吸道样本和血液样本。应尽量采集病例发病早期、使用抗菌药物治疗前的呼吸道样本,优先采集病例发病后1周内的下呼吸道样本,包括深部痰液、气管吸取物、肺泡灌洗液、胸腔穿刺液等,不具备上述样本采集条件时则采集口咽拭子、鼻咽拭子。如发现病情危重,或为禽畜等相关从业人员、医务人员、病原微生物实验室检测人员等高风险职业人员,应立即采集样本。血液样本尽量采集发病7天内的急性期以及间隔2—4周的血液样本(含抗凝和非抗凝血液),必要时采集间隔6—8周的血液样本(含抗凝和非抗凝血液)。

县级疾控机构收到样本后,应在24小时内开展呼吸道传染病多病原筛查,不具备条件的或检测结果为阴性的,应及时上送至地

市级疾控机构开展检测。地市级疾控机构收到样本后,应在 72 小时内依次开展呼吸道传染病多病原筛查,人感染新亚型流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状病毒、中东呼吸综合征病毒等重点呼吸道病原体的检测,以及靶向基因组测序,直至查明病原。仍未明确病原或不具备条件的,应将样本逐级上送至省级疾控机构和中国疾控中心开展基于基因组测序等方法的病原鉴定。各级疾控机构应将检测结果反馈下级疾控机构及送样单位。

如检出疑似新发突发病原体、新型病原体,应按照《关于开展新发突发传染病实验室报告与核实处置工作的通知》(国疾控综监测发〔2025〕10 号)等文件要求进行报告。病例测序序列应在 24 小时内逐级报送至中国疾控中心,病例原始样本尽快送往中国疾控中心,按国家有关规定进行复核。

病例相关样本的采集、包装、运送、实验室检测和保藏工作,应符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》(卫生部令第 45 号)、《人间传染的病原微生物菌(毒)种保藏机构管理办法》(卫生部令第 68 号)、《人间传染的病原微生物目录》(国卫科教发〔2023〕24 号)等国家相关生物安全管理规定。

4. 流行病学调查。县级疾控机构在接到监测病例报告后的 24 小时内完成初步流行病学调查,同时做好密切接触者和可疑共同暴露者信息登记、追踪和健康监测,必要时由地市级疾控机构指导开展。需要重点调查病例周围有无聚集性发病现象、有无高风险

职业史、可疑动物或动物制品接触史、可疑环境暴露史、境内外旅居史等。医疗机构应当配合疾控机构开展流行病学调查与现场处置工作,落实相应防控措施。检出常见多发病原感染所致的病例,按照现有相关规定采取措施进行病例管理和疫情防控。县级疾控机构应将相关流行病学调查情况及时报告地市级疾控机构。

5.公共卫生风险研判。地市级疾控机构收到流行病学调查情况后,应根据需要组织县级疾控机构开展风险研判,着重评估动物源性病原体持续溢出或者存在人传人风险,组织临床诊疗、传染病防控、病原检验等多领域专家,根据病例临床表现、流行病学调查情况及实验室检测结果,判定风险性质。风险评估结果应立即报告地市级疾控部门和省级疾控机构,同时反馈相关医疗机构和县级疾控部门。必要时由省级疾控机构直接组织开展风险评估,并及时将研判结果报告省级疾控部门和中国疾控中心。

6.订正报告。医疗机构应在收到实验室检测结果、明确病例诊断后,及时订正报告。对诊断已明确,但尚未列入传染病疫情网络直报的传染病,报告病例的医疗机构应在备注栏中注明已明确的病原名称。构成突发公共卫生事件的,县级疾控机构或医疗机构依法进行突发公共卫生事件报告。

7.先期处置措施。

(1)病例临床管理。按照《医院隔离技术标准》等有关要求,对聚集性不明原因肺炎病例,应当及时采取单间隔离治疗措施,经病原学确诊的相同病原体感染病例可以在同一间病房隔离治疗。原

则上,应选用标准负压型救护车,一车一人,隔离转运。

(2)个人防护。医务人员进行病例诊疗、检测、流行病学调查和卫生处置时,在实施标准预防的基础上,参照《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范》,根据感染风险采取相应的感染预防措施。必要时对接触病例的医务人员开展健康监测。

(3)医院感染控制。如病情允许,病例须佩戴医用外科口罩。病例物品应专用,尽量选择一次性诊疗用品,一次性餐具等生活物品。患者生活垃圾、一次性或可丢弃的衣物按感染性医疗废物处理。在病例诊疗期间,应加强其所在场所的环境消毒。

8.衔接应急响应。构成突发公共卫生事件的,疾控部门应基于风险研判结果,按照应急预案及时启动应急响应,依法采取必要的控制、消除和减轻事件危害的措施。

三、监测分析与质量控制

(一)数据分析与利用。各级疾控机构对辖区内病例数据定期进行分析评估。省级疾控机构应结合前置软件数据以及临床症候群监测、病原微生物实验室监测等其他多源监测数据进行综合分析,及时发现疫情风险苗头。各级疾控机构将监测分析结果及时反馈至下级疾控机构、医疗机构等有关单位,支持临床诊断、风险人群防护、疫情处置防控等工作。

(二)业务培训。各级疾控机构加强本辖区监测工作业务培训和技术指导,重点加强病例识别报告、流行病学调查、实验室检测方法、监测数据分析方法、质量控制方法等相关技术培训。医疗机

构加强重点科室医务人员技术培训,重点加强病例识别发现、流行病学调查技术培训。

(三)质量控制。地市级和县级疾控机构应做好监测数据及结果的质量控制,省级疾控机构加强对辖区内医疗机构病例报告情况抽查复核,组织开展实验室室间质控。医疗机构指定科室负责监测工作,定期对本单位监测工作进行质量控制,重点检查有无漏诊、漏报。

四、组织管理及职责分工

(一)国家疾控局。会同国家卫生健康委、国家中医药局组织编制和指导实施全国监测方案,组织对监测实施情况和监测效果进行评价。

(二)省级及以下疾控部门。会同本级卫生健康、中医药部门组织实施本辖区监测工作,做好人员经费保障,每年组织1次指导评估;指导医疗机构、疾控机构协同开展病例的发现、报告、诊疗、流行病学调查、检测和管控工作;提高医疗机构前置软件采集数据质量,鼓励疾控机构和医疗机构利用信息技术辅助开展监测。

(三)中国疾控中心。

1.负责全国监测工作的业务管理,制定监测相关技术文件,开展全国监测工作的技术培训、指导、质控、评估工作。

2.负责对各省份按照规定送国家进行复核的样本、宏基因组测序后仍未明确病原的样本以及疑似新发罕见和新型病原体进行复核鉴定。

3.负责全国监测相关信息系统的完善维护,提供技术支持,积极利用前置软件等提高主动发现能力。承担对全国监测数据的分析和风险评估。

(四)省级及以下疾控机构。

1.各级疾控机构落实本辖区内监测工作,加强对辖区内医疗机构的业务指导,组织开展业务管理、质量控制、技术培训等工作。

2.各级疾控机构组织开展核酸检测、病原鉴定、基因测序等工作,开展流行病学调查、监测资料分析、公共卫生风险研判、结果反馈。

3.省级疾控机构负责在省统筹平台开发和运行聚集性肺炎风险自动识别模型。

(五)医疗机构。

1.负责本单位监测相关任务的具体实施,落实专人负责相关业务管理,加强病例报告、流行病学史询问和样本采集送检等技术指导培训。

2.按要求开展病例发现报告、询问流行病学史、采样检测、先期处置等工作。

3.落实医院内前置软件等相关信息系统的运行维护,做好业务培训和质量控制。

附件:聚集性肺炎风险识别规则

附件

聚集性肺炎风险识别规则

标签编号	标签名称	判定规则	电子病历 字段来源 表单	电子病历 字段名称	字段 类型
1	发热	包含“发热”（同义词：发烧，发烫，体温高，体温超过正常，体温增高，体温升高，体温上升，体温最高达，体温升至，体温最高可达，低热，低烧，中热，高热，高烧，身体温度升高、体热、升温、热感、热病、热势、体烫、热症、热潮、稽留热、弛张热、间歇热、回归热、不规则热、体温高、体温异常、热度加剧、热邪入侵、热度不退、体内有热、体温异常高、身体烫手、体内热盛、热度上升、热性病、体温过热、热度不散、体内积热、热度高、波状热、中度热、高度热、身热、热峰、寒战、寒颤、打寒战、畏寒、恶寒、发抖、战栗、先寒后热、恶寒发热），且不存在无发热、未（见、诉）发热、不伴发热、没有发热、否认发热、体温恢复正常、无寒战、未见寒战、否认畏寒、无畏寒的文字	诊疗活动 信息表	主诉/ 现病史	必填
			门（急）诊 病历	主诉/ 现病史	必填
			门（急）诊 留观记录	主诉/ 现病史	必填
			入院记录	主诉/ 现病史	必填
			住院首次 病程记录	主诉/ 现病史	建议 填
2	体温	基础体温测定，体温监测，体温测量，体温检查，监测体温数字，包含“℃”或“摄氏度”或“度”或“°”，且之前的数字≥“37.3”；体温+数值≥“37.3”；T/TMAX+数值≥“37.3”	同发热标 签电子病 历字段来 源表单	主诉/ 现病史	建议 填
3	肺炎 影像	包含“肺部炎症”或“肺炎”或“肺部阴影”，且之前不存在“无”、“没有”、“未见”、“未有”的文字	检查报告	检查报告 结果-客观 所见/检查 报告结果- 主观提示	必填

4	肺炎诊断	前三位为J12-J18	诊疗活动信息表	西医疾病诊断编码	必填
			门（急）诊病历	初步诊断-西医诊断代码	必填
			门（急）诊留观记录	初步诊断-西医诊断代码	必填
			入院记录	初步诊断-西医诊断编码/修正诊断-西医诊断代码/确定诊断-西医诊断代码	必填/建议填/必填
			住院首次病程记录	初步诊断-西医诊断编码/鉴别诊断-西医诊断代码	建议填
			住院病案首页	出院诊断-主要西医诊断代码	必填
			出院记录	出院诊断-西医诊断代码	必填
5	常见病原	包含以下任一字样： ①新型冠状病毒 新冠 新冠病毒 ②流感病毒 流感 流行性感 流行性感冒病毒 甲型H3N2 流感病毒 甲型H1N1 流感病毒 甲型流感病毒 甲流病毒 甲流 流感A B（Y）流感病毒 B（V）流感病毒 乙型流感病毒 乙流病毒 乙流 ③呼吸道合胞病毒 RSV ④腺病毒 ⑤人偏肺病毒 ⑥副流感病毒 ⑦普通冠状病毒 冠状病毒（低致病性） ⑧博卡病毒	检验报告项目	院内检验项目名称	必填

		⑨鼻病毒 ⑩肠道病毒 ⑪A族链球菌 ⑫百日咳 百日咳鲍特氏菌 ⑬肺炎链球菌 ⑭流感嗜血杆菌 ⑮军团菌 博兹曼氏军团菌 嗜肺军团菌 ⑯肺炎克雷伯菌 肺炎克雷伯氏菌 ⑰肺炎支原体 肺支 ⑱曲霉菌 ⑲隐球菌 ⑳鹦鹉热衣原体 ㉑肺炎衣原体			
6	病原 检验 阳性	包含“阳性”字样：阳性或弱阳性	检验报告 项目	标化检验 定性结果 名称	必填
7	家庭 住址	同住、同生活，距离其他肺炎病例住址在一定范围阈值内，建议阈值为10米。	患者基本 信息表	现住详细 地址	必填
8	学校/ 工作 单位	同学习、同工作，距离其他肺炎病例学校/工作单位在一定范围阈值内，建议阈值为10米。	患者基本 信息表	工作单位/ 学校名称	必填

注：建议在开展聚集性肺炎风险识别时，参照使用规则表达式：(1 OR 2) AND (3 OR 4) AND NOT (5 AND 6) AND (7 OR 8)。即需同时满足以下全部条件：1.存在发热或体温异常表现；2.存在肺炎影像学表现或肺炎诊断；3.排除常见病原检测阳性；4.存在病例间同住、同生活或同学习、同工作的流行病学关联。

国家疾控局综合司

2026年9月7日印发

校对：张宸罡